PROTOCOLO DE CORRECCIÓN INSULÍNICA EN HIPERGLICEMIA PREPRANDIAL PARA PACIENTES EN SERVICIOS DE MEDICINA

Código Identificación	HCSFB 168
Número Edición	Primera
Fecha Elaboración	Abril 2026
Fecha Revisión	Abril 2031
Vº Bueno OFICYSP	**Valeska Vivallo Poblete**

Elaborado	Revisado	Aprobado
Dr. Fernando Alvarado Caro Médico Cirujano en etapa de destinación (EDF) HCSFB Subrogante Servicio de Medicina **Dr. Vicente Ruf Toledo** Médico Cirujano en etapa de destinación (EDF) HCSFB	**Dra. Micaela Fasani Montagna** Subdirectora médica HCSFB **Dr. Ignacio San Martin** Médico Cirujano en etapa de destinación (EDF) Jefe Servicio de Medicina	**Dr. Álvaro Lagos Llanos** Director HCSFB
Fecha: **Marzo 2026**	**Fecha:** **Abril 2026**	**Fecha:** **Abril 2026**

Índice

1. Introducción 3

2. Objetivo General 4

3. Alcance 4

4. Responsables de la ejecución 4

5. Referencias 5

6. Glosario y/o definiciones 5

7. Población objetivo 8

a. Criterios de inclusión 8

b. Criterios de exclusión 8

8. Aplicación e ingreso al protocolo 9

9. Clasificación por perfil de insulinosensibilidad 9

a. Grupo insulinosensible 10

b. Grupo intermedio 11

c. Grupo insulinoresistente 11

10. Reevaluación 12

11. Criterios para notificación a médico 12

12. Consideraciones finales 13

13. Distribución 13

14. Responsabilidad del Encargado: 13

15. Registro 14

a. Ficha clínica 14

b. Ficha de enfermería 14

16. Tabla de Modificaciones y/o correcciones 14

17. Anexos 15

a. Flujograma operativo 15

b. Planillas con esquema correcional de insulina cristalina (U/kg) por perfil de insulinosensibilidad 16

c. Plataforma web con protocolo integrado (vista general y resultado) 17

d. Planillas con esquema correccional para usuario de 70 kg por perfil de insulinosensibilidad 18

1. Introducción

La hiperglicemia intrahospitalaria es una condición frecuente en pacientes hospitalizados en servicios de medicina, tanto en personas con diabetes mellitus previamente conocida como en aquellas que presentan hiperglicemia en el contexto de enfermedad aguda. Su elevada prevalencia en este escenario la convierte en un problema clínico habitual y relevante durante la hospitalización.

Su presencia se asocia a mayor complejidad asistencial, necesidad de ajustes terapéuticos y prolongación de la estadía hospitalaria. A su vez, la hospitalización prolongada, la enfermedad aguda y la respuesta al estrés pueden favorecer o perpetuar la hiperglicemia, estableciéndose una relación bidireccional entre ambas condiciones.

Dado que los requerimientos de insulina no son uniformes entre los distintos pacientes hospitalizados, y que existen variables individuales clínicas y metabólicas que modifican la sensibilidad a la insulina, se establece el presente protocolo con el fin de estandarizar la corrección insulínica preprandial de manera individualizada, según el perfil de insulinosensibilidad de cada paciente.

2. Objetivo General.

Estandarizar la corrección insulínica preprandial en pacientes hospitalizados en Servicio de Medicina, de acuerdo con su perfil de insulinosensibilidad, con el propósito de optimizar el control glicémico intrahospitalario y reducir el riesgo de hipoglicemia e hiperglicemia persistente.

3. Alcance

Este protocolo será aplicable a pacientes adultos hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital de Bulnes y constituye una herramienta de apoyo al juicio clínico. **Su utilización no reemplaza la indicación médica ni otras estrategias de manejo glicémico que el médico tratante o especialista estime pertinentes**, incluyendo esquemas basales, basal-correccionales, antidiabéticos orales u otras medidas terapéuticas, las cuales quedarán a criterio médico y escapan al alcance del presente protocolo.

Los pacientes inicialmente excluidos de este protocolo, así como aquellos que cuenten con un protocolo previo, podrán ser reevaluados y ser sujetos de un nuevo protocolo de corrección insulínica si así se estima clínicamente pertinente.

4. Responsables de la ejecución

4.1.- Médico tratante:

- Confirmar criterios de inclusión y exclusión.
- Clasificar al paciente según perfil de insulinosensibilidad.
- Indicar la corrección insulínica correspondiente.
- Reevaluar la respuesta clínica.
- Definir ajuste o escalamiento terapéutico cuando corresponda.
- Consignar en ficha clínica la implementación del protocolo.

4.2.- Enfermera/o:

- Verificar indicación médica vigente.
- Supervisar cumplimiento del control glicémico.
- Administrar la insulina según indicación.
- Registrar glicemias y dosis administradas.
- Comunicar oportunamente eventos relevantes.

4.3.- TENS

- Realizar controles de glicemia capilar según horario indicado.
- Informar resultados a enfermería.
- Colaborar en la vigilancia posterior a la corrección.

5. Referencias

- American Diabetes Association Professional Practice Committee. (2026). 16. Diabetes care in the hospital: Standards of care in diabetes—2026. Diabetes Care, 49(Suppl. 1), S339–S355.

- Grassi, B., Álvarez, P., Kara, F., Strodthoff, K., & Maiz, A. (2021). Prevalencia de hiperglicemia y su relación con el tiempo de estadía en un hospital terciario. Revista Médica de Chile, 149(2), 210–216. https://doi.org/10.4067/S0034-98872021000200210

- Korytkowski, M. T., Muniyappa, R., Antinori-Lent, K., Donihi, A. C., Drincic, A., Hirsch, I. B., McDonnell, M. E., Rushakoff, R. J., Umpierrez, G. E., & Watts, N. B. (2022). Management of hyperglycemia in hospitalized adult patients in non-critical care settings: An endocrine society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 107(8), 2101–2128. https://doi.org/10.1210/clinem/dgac278

- Ministerio de Salud. (2010). Guía clínica diabetes mellitus tipo 2. Ministerio de Salud de Chile.

- Ministerio de Salud. (2017). Encuesta Nacional de Salud 2016–2017: Primeros resultados. Ministerio de Salud de Chile.

6. Glosario y/o definiciones

- **Diabetes mellitus tipo 2:** enfermedad metabólica crónica caracterizada por hiperglicemia secundaria a grados variables de resistencia a la insulina y deterioro progresivo de la secreción de insulina.
- **Hiperglicemia persistente:** presencia de glicemia **>180 mg/dL** pese a encontrarse el paciente en manejo con esquema correccional y/o basal.
- **Insulinosensibilidad:** grado de respuesta biológica de un paciente a una determinada dosis de insulina. A mayor insulinosensibilidad, mayor efecto hipoglicemiante con menores dosis.

- **Insulinoresistencia:** condición en la cual el paciente presenta menor respuesta biológica a la acción de la insulina, requiriendo dosis mayores para obtener un efecto glicémico comparable.
- **Hiperglicemia de etiología desconocida:** elevación de glicemia en la que no se ha precisado adecuadamente la causa o el contexto clínico subyacente.
- **Insulina rápida:** insulina de acción corta, utilizada principalmente para cobertura prandial y corrección de hiperglicemia.
- **Insulina ultrarrápida:** análogo de insulina de inicio de acción más precoz que la insulina rápida convencional, utilizado para cobertura prandial y corrección.
- **Insulina lenta:** insulina de acción prolongada utilizada para cubrir requerimientos basales.
- **Insulina NPH:** insulina de acción intermedia, utilizada como insulina basal.
- **Esquema basal-bolo:** estrategia de insulinoterapia que combina una insulina basal con insulina prandial o de bolo.
- **Esquema basal:** estrategia de insulinoterapia basada en el uso de insulina de acción intermedia o prolongada para cubrir requerimientos basales.
- **Síndrome diabético agudo:** descompensación metabólica aguda asociada a diabetes mellitus, que incluye el **síndrome hiperosmolar hiperglicémico (SHH)** y la **cetoacidosis diabética (CAD)**.
- **Síndrome hiperosmolar hiperglicémico (SHH):** complicación aguda de la diabetes caracterizada por hiperglicemia severa, hiperosmolaridad y deshidratación significativa, habitualmente sin cetosis importante.
- **Cetoacidosis diabética (CAD):** complicación aguda de la diabetes caracterizada por hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica.
- **Adecuación del esfuerzo terapéutico (AET):** ajuste proporcional de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas según el pronóstico, objetivos de cuidado, condición clínica global y beneficios esperables.
- **Sepsis:** disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección.
- **Enfermedad renal crónica (ERC):** alteración estructural o funcional renal persistente en el tiempo, con repercusión clínica variable.
- **Hepatopatía crónica:** enfermedad hepática persistente de evolución prolongada que puede alterar el metabolismo de la glucosa y la respuesta a la insulina.

- **Fragilidad:** síndrome clínico de disminución de la reserva fisiológica y aumento de la vulnerabilidad frente a eventos agudos.
- **Síndrome de ovario poliquístico (SOP):** trastorno endocrino-metabólico frecuentemente asociado a resistencia a la insulina y alteraciones del metabolismo glucídico.
- **Hiperglicemia clínica:** elevación de la glicemia por sobre los valores esperados para el contexto clínico. Como referencia general, suele considerarse hiperglicemia una glicemia **>140 mg/dL alejada por al menos 2 horas de la última comida**. Se considera como hiperglicemia importante cuando los valores son **>180 mg/dL**.
- **Hipoglicemia:** disminución de la glicemia a valores inferiores a lo normal. Habitualmente se considera una glicemia <70 mg/dL**.**
- **Glicemia marcadamente elevada:** glicemia >350 mg/dL tomada al menos 2 horas posterior a la última comida**.**
- **HbA1c:** hemoglobina glicosilada, expresada habitualmente en porcentaje, utilizada como marcador del promedio de control glicémico de los últimos 2 a 3 meses.
- **Glicemia preprandial:** glicemia obtenida antes de una comida, habitualmente antes de desayuno, almuerzo o cena.
- **Hiperglicemia con requerimientos correccionales:** operativamente, corresponde a cualquiera de las siguientes situaciones:
    - una toma aislada de glicemia ≥200 mg/dL**;**
    - glicemia de ayuno ≥140 mg/dL**;**
    - glicemias preprandiales **≥**160 mg/dL en tres o más tomas separadas o **≥**180 mg/dL en dos o más tomas separadas.
- **Terapia corticoidal:** uso de corticosteroides sistémicos como parte del tratamiento de una condición clínica aguda o crónica. Puede asociarse a aumento de la glicemia y a mayor requerimiento insulínico, especialmente con dosis intermedias o altas, administración repetida o uso prolongado.
- **Antidiabéticos orales (ADO):** grupo de fármacos administrados por vía oral utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, orientados a mejorar el control glicémico mediante distintos mecanismos, tales como aumento de la sensibilidad a la insulina, disminución de la producción hepática de glucosa, estimulación de la secreción pancreática de insulina o aumento de la excreción urinaria de glucosa.

7. Población objetivo

Pacientes adultos hospitalizados en Servicio de Medicina que presenten diabetes mellitus tipo 2 o hiperglicemia intrahospitalaria con criterio médico de corrección preprandial.

a. Criterios de inclusión

Podrán ingresar a este protocolo los pacientes que cumplan los siguientes criterios:

- Edad igual o mayor a 18 años.
- Hospitalización en cualquiera de las unidades del Servicio de Medicina.
- Diabetes mellitus tipo 2 conocida, o hiperglicemia intrahospitalaria con indicación médica de corrección[1].
- Condición clínica compatible con manejo subcutáneo en sala no crítica.
- Indicación de control de glicemia capilar y corrección insulínica preprandial.

b. Criterios de exclusión

Quedarán excluidos de este protocolo los pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones:

- Diabetes mellitus tipo 1.
- Síndrome hiperglicémico hiperosmolar.
- Cetoacidosis diabética.
- Embarazo, sea fisiológico o no.
- Hipoglicemia sintomática o persistente, o antecedente reciente de hipoglicemia clínicamente relevante.
- Esquema basal, basal-bolo o insulinización ya definido por especialista.
- Esquema correccional con insulina cristalina o insulina ultrarrápida definido por especialista.
- Indicación clínica basal-bolo posterior a evaluación de ingreso.
- Contraindicación para uso de insulina cristalina subcutánea.
- Paciente crítico, inestable o con adecuación terapéutica (AET).
- Hiperglicemia grave y persistente y/o glicemia marcadamente elevada sin etiología precisada, cuando exista riesgo de subestimar requerimientos insulínicos o de omitir una condición subyacente que requiera abordaje específico.

[1] Operativamente se considera como hiperglicemia con requerimientos correccionales, cualquier toma aislada de glicemia ≥ 200 mg/dL, a una glicemia de ayuno ≥140 mg/dL o a hiperglicemias preprandiales ≥160 mg/dL en tres o más tomas separadas o hiperglicemias preprandiales ≥180 mg/dL en dos o más tomas separadas.

8. Aplicación e ingreso al protocolo

La clasificación inicial deberá realizarse al momento de generar la solicitud de hospitalización del paciente desde el Servicio de Urgencia, al ingreso al Servicio de Medicina o al momento de decidir el inicio de corrección insulínica.

La corrección se aplicará en contexto preprandial, sobre la base del control de glicemia capilar previo a desayuno, almuerzo y cena, o en otros horarios cuando exista indicación médica específica, mediante un esquema personalizado para cada paciente que considera el perfil de insulinosensibilidad y los valores antropométricos (peso). Para facilitar la ejecución y aplicación práctica, deberán utilizarse las planillas Excel disponibles en los servicios clínicos o la herramienta web institucional destinada a apoyar la clasificación y selección de dosis (Anexos b y c)**. En forma excepcional si no se logra realizar una estimación confiable de los valores antropométricos del usuario, se podrán estimar los valores correccionales en base a un peso estandarizado de 70 kg para cada perfil de insulinosensibilidad debiendo estar dichos protocolos disponibles en los servicios de enfermería de cada servicio** (Anexo d).

El insumo actualmente disponible para la administración de insulina cristalina permite correcciones en incrementos de 2 UI de acuerdo con las jeringas disponibles al momento de la elaboración del presente protocolo. En caso de disponerse en el futuro de jeringas que permitan dosificación en incrementos de 1 UI, deberán ajustarse las tablas de corrección y la herramienta web institucional para adecuarlas a dicha nueva capacidad de dosificación. Esta modificación deberá ser debidamente comunicada a los equipos clínicos antes de su implementación.

9. Clasificación por perfil de insulinosensibilidad

Para clasificar al paciente según perfil de insulinosensibilidad, se deberán considerar variables clínicas y metabólicas disponibles al ingreso o durante la hospitalización, las cuales se relacionan con el perfil individual de cada usuario, entre estas se encuentran:

- Edad.
- Peso estimado.
- Índice de masa corporal, si se dispone.
- Fragilidad clínica. Bajo peso, caquexia o desnutrición.
- Glicemias de ingreso.
- Hemoglobina glicosilada, si se encuentra disponible.
- Triglicéridos, si se encuentran disponibles.
- Uso actual o reciente de corticoides sistémicos.
- Presencia de infección activa o sepsis.

- Postoperatorio mayor reciente.
- Hepatopatía aguda o crónica avanzada.
- Enfermedad renal crónica y VFG, si se encuentra disponible.
- Tratamiento hipoglicemiante previo.
- Uso previo de insulina.
- Dosis previa de insulina expresada en U/kg, si se dispone.
- Otros antecedentes clínicos asociados a insulinoresistencia o a mayor riesgo de hipoglicemia.

La disponibilidad de estos antecedentes dependerá de la condición clínica particular de cada paciente y de la información efectivamente obtenida durante su evaluación. Sin perjuicio de ello, y dado que estas variables contribuyen a una clasificación más precisa, **se solicita que los servicios de Urgencia y Medicina aseguren, de manera coordinada, e idealmente previo a la evaluación médica, el registro lo más completo posible de antecedentes clínicos, metabólicos y antropométricos pertinentes, incluyendo al menos peso, talla e índice de masa corporal.**

La clasificación se realizará en tres grupos: insulinosensible, intermedio e insulinoresistente. La definición final corresponderá al médico tratante, considerando la evaluación integral del paciente

a. Grupo insulinosensible

Corresponde a pacientes con mayor probabilidad de responder intensamente a dosis bajas de insulina y con mayor riesgo de hipoglicemia frente a esquemas estándar.

- <u>Criterios mayores</u>
    - HbA1c menor de 7%, si se dispone.
    - Enfermedad renal crónica avanzada, especialmente con VFG menor de 30 ml/min.
    - Hepatopatía avanzada.
- <u>Criterios menores</u>
    - Glicemia de ingreso entre 140 y 179 mg/dL.
    - Edad mayor de 75 años.
    - IMC menor de 22.
    - Caquexia.
    - Bajo peso o fragilidad.
    - Triglicéridos menores de 150 mg/dL.

Corrección aproximada entre 0,03 y 0,09 U/kg.

Ingreso: Al menos 1 criterio mayor, o 2 o más criterios menores.

Perfil habitual: Pacientes añosos, Pacientes frágiles, Pacientes de bajo peso, Pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, Pacientes con hepatopatía avanzada. **Pacientes con mayor riesgo de hipoglicemia.**

b. Grupo intermedio

Corresponde a pacientes que no cumplen criterios suficientes de insulinosensibilidad ni de insulinoresistencia marcada.

Criterios orientadores

- IMC entre 25 y 29,9.
- Diabetes mellitus tipo 2 conocida en tratamiento con antidiabéticos orales.
- Uso previo de insulina menor de 0,5 U/kg/día, si corresponde.
- Glicemia de ingreso entre 180 y 249 mg/dL.
- HbA1c entre 7 y 8,9%, si se dispone.
- Triglicéridos entre 150 y 199 mg/dL.
- Edad entre 40 y 75 años.
- Estabilidad clínica, sin sepsis ni postoperatorio mayor reciente.

Corrección aproximada entre 0,03 y 0,14 U/kg.

Ingreso: No cumplir criterios para grupo insulinosensible. No cumplir criterios para grupo insulinoresistente.

c. Grupo insulinoresistente

Corresponde a pacientes con mayor probabilidad de requerir dosis más altas de insulina para lograr corrección de la hiperglicemia.

Criterios mayores

- HbA1c igual o mayor a 9%, si se dispone.
- Uso activo de corticoides sistémicos.
- Infección activa o sepsis.
- Postoperatorio mayor reciente.
- Uso previo de insulina NPH mayor de 0,5 U/kg.

Criterios menores

- IMC mayor o igual a 30.
- Glicemia de ingreso igual o mayor a 250 mg/dL.
- Síndrome de ovario poliquístico en mujeres jóvenes.
- Triglicéridos iguales o mayores a 200 mg/dL.

Corrección aproximada entre 0,06 y 0,20 U/kg.

Ingreso: Al menos 1 criterio mayor, o 2 o más criterios menores, siempre que no existan criterios que obliguen a clasificarlo como insulinosensible.

10. Reevaluación

El paciente deberá ser reevaluado por el médico tratante frente a las siguientes situaciones:

- Hiperglicemia persistente pese a correcciones sucesivas;
- hipoglicemia; cambio relevante del estado clínico;
- inicio o suspensión de corticoides;
- deterioro de función renal o hepática;
- cambio importante en la ingesta o condición nutricional.

La corrección aislada no deberá mantenerse como única estrategia en pacientes con hiperglicemia persistente, debiendo evaluarse ajuste o inicio de esquema basal o basal-correccional.

11. Criterios para notificación a médico

El equipo de enfermería y/o TENS deberá informar oportunamente al médico tratante ante:

- Glicemia preprandial menor de 70 mg/dL;
- hipoglicemia sintomática;
- hiperglicemia persistente pese a corrección;
- glicemias marcadamente elevadas;
- deterioro clínico o sospecha de descompensación metabólica aguda;
- imposibilidad de administración segura por ayuno, vómitos o cambio clínico relevante.

La vigilancia de estas alteraciones y su respectiva conducta es responsabilidad del estamento médico, sin embargo, la notificación oportuna de las mismas forma

parte de las responsabilidades del estamento de enfermería y estamento TENS, debiendo dejar registro en la ficha de enfermería del mismo.

12. Consideraciones finales

La utilización de planillas Excel disponibles en los servicios clínicos o de la herramienta web institucional tendrá carácter de apoyo operativo y no reemplazará la evaluación clínica ni la indicación médica formal. En caso de dudas respecto al esquema insulínico o la indicación del mismo, cualquier funcionario debe dirigir las consultas al médico tratante.

13. Distribución

- Dirección.
- Subdirección Médica.
- Servicio clínico Médico Quirúrgico.
- Servicio clínico Ginecología y obstetricia.
- Servicio de Urgencia.
- Farmacia
- Oficina Calidad y Seguridad del Paciente

14. Responsabilidad del Encargado:

La responsabilidad de la ejecución de este protocolo recaerá en los médicos encargado y subrogante del servicio de medicina teniendo como objetivos:

- Supervisar su implementación y correcta aplicación en el Servicio de Medicina.
- Reforzar su uso entre médicos, enfermería y personal clínico involucrado.
- Promover el registro de variables clínicas y antropométricas relevantes, incluyendo peso, talla e IMC cuando sea factible.
- Monitorear eventos adversos, dificultades de aplicación y observaciones reportadas por los equipos clínicos.
- Analizar dicha información y proponer ajustes a las tablas, planillas y herramientas de apoyo.
- Adecuar las tablas y la herramienta operativa en caso de cambios en los insumos disponibles, incluyendo la eventual disponibilidad de jeringas con dosificación de 1 UI.
- Difundir oportunamente las actualizaciones que se realicen al protocolo.

Se establecen como líneas de mejora continua:

- Perfeccionar el protocolo según experiencia de uso y resultados observados.

- Desarrollar esquemas complementarios basados en la misma lógica de insulinosensibilidad, incluyendo estrategias basal-bolo o basal-bolo plus.
- Elaborar protocolos específicos para grupos actualmente excluidos, cuando exista factibilidad de aplicación segura, incluyendo pacientes con diabetes tipo 1 clínicamente estables.
- Mejorar progresivamente la disponibilidad de variables clínicas, metabólicas y antropométricas para una clasificación más precisa.

15. Registro

Deberá quedar registro formal de la aplicación del protocolo, incluyendo siempre la fecha, hora de implementación y profesional responsable de su realización.

a. Ficha clínica

Deberá consignarse en ficha clínica, al menos: ingreso del paciente al protocolo; fecha y hora de implementación; profesional que realiza la clasificación e indicación; grupo clínico asignado; criterios clínicos relevantes considerados para su clasificación; indicación del esquema de corrección correspondiente; reevaluaciones médicas; modificaciones posteriores del protocolo; suspensión del protocolo, cuando corresponda.

b. Ficha de enfermería

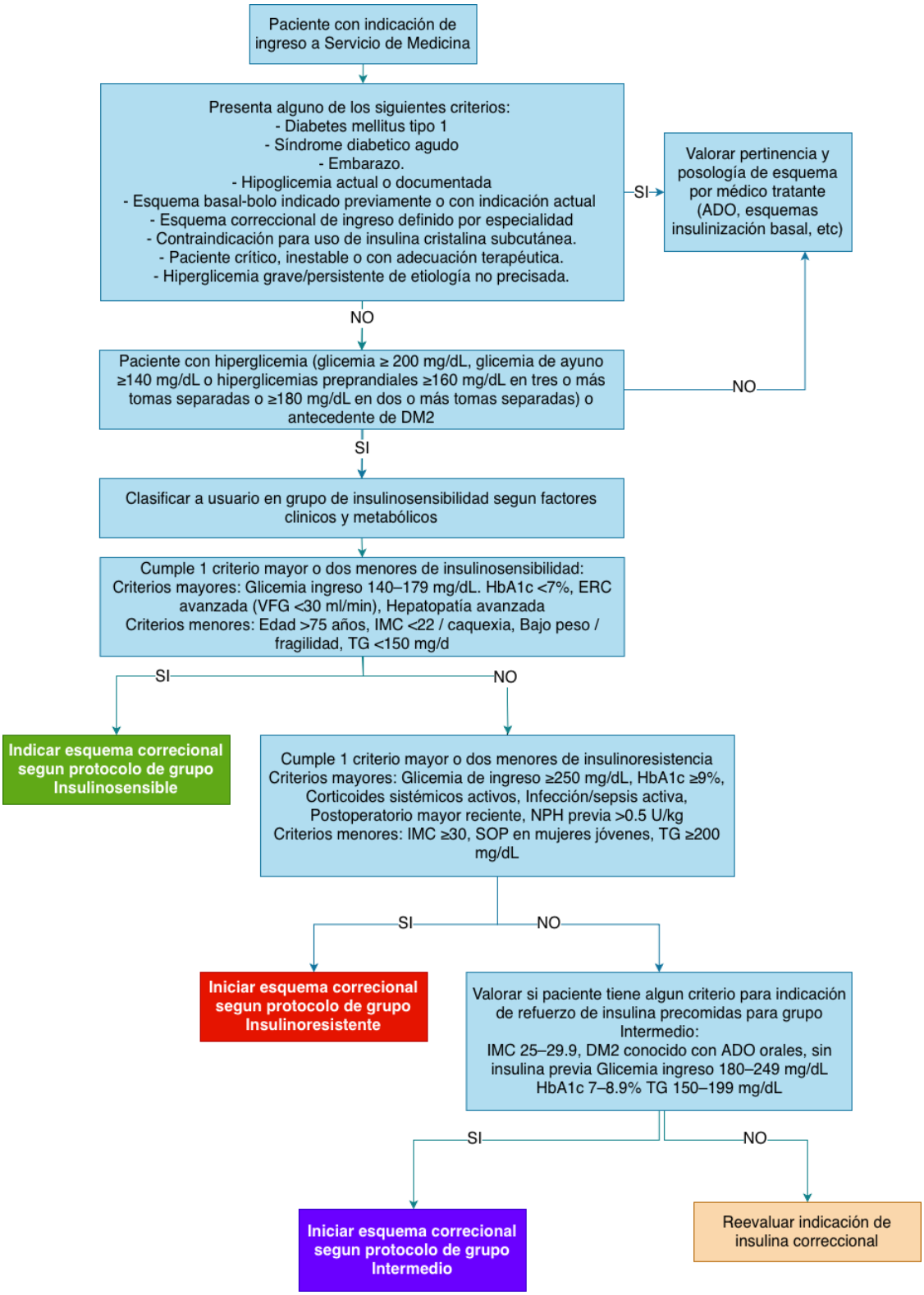
Deberá consignarse en ficha de enfermería, al menos: glicemias capilares realizadas; horario del control; dosis de insulina administrada; horario de administración; eventual rechazo, suspensión o imposibilidad de administración; presencia de síntomas sugerentes de hipoglicemia o eventos adversos; comunicación al médico tratante cuando corresponda.

16. Tabla de Modificaciones y/o correcciones

Corrección	Fecha	Descripción de Modificación	Publicado en	Nº documento
	Abril 2026	Elaboración del Documento		

17. Anexos

a. Flujograma operativo



b. Planillas con esquema correcional de insulina cristalina (U/kg) por perfil de insulinosensibilidad

PROTOCOLO DE CORRECCIÓN INSULINA - GRUPO SENSIBLE

PESO PACIENTE (KG)	0		
GLICEMIA DESDE	Glicemia hasta	U/kg	Dosis (U) redondeada a par
140	159	0,03	0
160	179	0,03	0
180	199	0,03	0
200	219	0,03	0
220	249	0,06	0
250	999	0,09	0

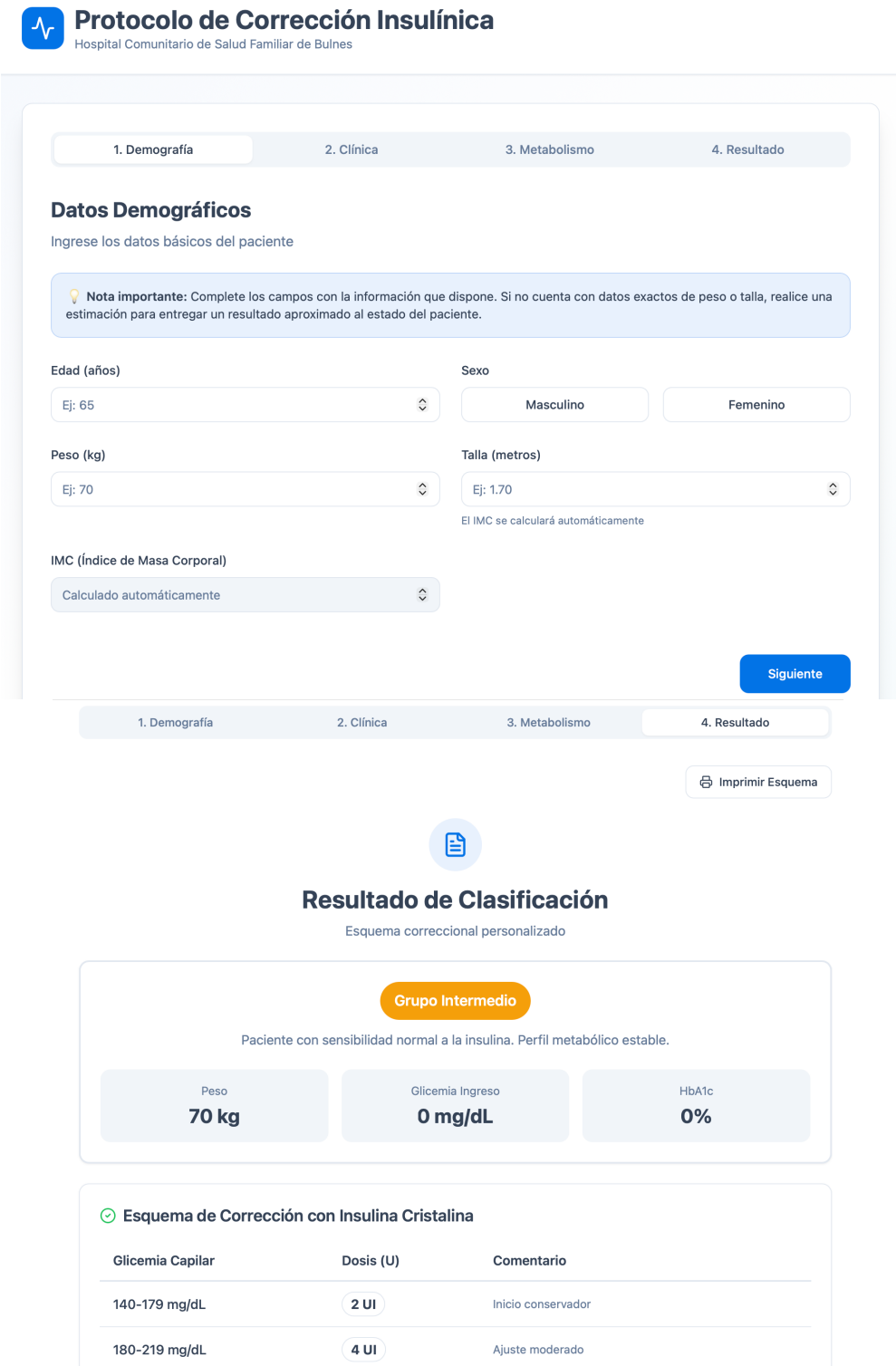
PROTOCOLO DE CORRECCIÓN INSULINA - GRUPO INTERMEDIO

PESO PACIENTE (KG)	0		
GLICEMIA DESDE	Glicemia hasta	U/kg	Dosis (U) redondeada a par
140	179	0,03	0
180	219	0,06	0
220	249	0,06	0
250	299	0,09	0
300	349	0,11	0
350	999	0,14	0

PROTOCOLO DE CORRECCIÓN INSULINA - GRUPO RESISTENTE

PESO PACIENTE (KG)	0		
GLICEMIA DESDE	Glicemia hasta	U/kg	Dosis (U) redondeada a par
140	179	0,06	0
180	219	0,09	0
220	249	0,11	0
250	299	0,14	0
300	349	0,17	0
350	999	0,2	0

c. Plataforma web con protocolo integrado (vista general y resultado)



Disponible en: https://hola-verse-greeting.lovable.app

d. Planillas con esquema correccional para usuario de 70 kg por perfil de insulinosensibilidad

Protocolo de corrección insulina – Grupo Sensible

Peso paciente (kg)	70		
Glicemia desde	Glicemia hasta	U/kg	Dosis (U) redondeada a par
140	159	0,03	**2**
160	179	0,03	**2**
180	199	0,03	**2**
200	219	0,03	**2**
220	249	0,06	**4**
250	999	0,09	**6**

Protocolo de corrección insulina - Grupo Intermedio

Peso paciente (kg)	70		
Glicemia desde	Glicemia hasta	U/kg	Dosis (U) redondeada a par
140	179	0,03	2
180	219	0,06	4
220	249	0,06	4
250	299	0,09	6
300	349	0,11	8
350	999	0,14	10

Protocolo de corrección insulina - Grupo Resistente

Peso paciente (kg)	70		
Glicemia desde	Glicemia hasta	U/kg	Dosis (U) redondeada a par
140	179	0,06	4
180	219	0,09	6
220	249	0,11	8
250	299	0,14	10
300	349	0,17	12
350	999	0,2	14